

Abord et examen psychiatrique d'un patient

Dr Sahnoun

- ✓ L'examen clinique en psychiatrie va se dérouler en plusieurs étapes :
 - Phase descriptive avec recherche de signes et de symptômes.
 - Phase syndromique, qui permet le regroupement de ces signes et symptômes en grands syndromes
 - Phase de diagnostic de trouble psychiatrique prenant en considération les aspects évolutifs (temporalité) ainsi que les aspects environnementaux
 - L'examen physique qui permet de rechercher des signes physiques associés aux troubles psychiatriques ; des comorbidités non psychiatriques ; les complications ; aider au choix du traitement psychotrope ; et surtout orienter vers un diagnostic différentiel.
- ✓ Le patient étant régulièrement conduit à évoquer des éléments d'intimité ou sources de détresse, parfois en présence de sa famille, l'attitude se doit de respecter les grands principes suivants :
 - Ecoute attentive ;
 - Implication ;
 - Discrétion et préservation de la confidentialité des entretiens ;
 - Regard positif inconditionnel : sollicitude sans jugement ;
 - Sentiment de sécurité ;
 - Empathie = aptitude du clinicien à « percevoir avec précision le système interne de référence d'autrui, avec les composantes émotionnelles et les significations qui s'y rapportent, comme s'il était cette autre personne, mais sans jamais perdre de vue ce comme si » (C. Rogers) ;
 - Authenticité ;
 - Compétence ;
 - Respect.
- ✓ L'objectif de l'examen psychiatrique est de **repérer les signes et symptômes psychiatriques** en favorisant une alliance de qualité (pour un examen de qualité) pour faire un diagnostic qui permettra de réaliser une prise en charge adaptée. Ainsi, un objectif de l'examen est aussi **d'établir une alliance avec le patient**. Il est important que le patient puisse ressortir d'un examen médical, avec le sentiment qu'il a trouvé un intérêt dans l'évaluation clinique réalisée, c'est à dire qu'il a été compris et entendu par le médecin.

A terme l'observation psychiatrique comportera les éléments suivants :

A. Identité :

Nom

Prénom
 Age
 Fratrie
 Origine
 Demeurant à
 Profession
 Niveau de scolarité

B. Motif d'hospitalisation

C. Antécédents

- Personnels :

Médicaux
 Chirurgicaux
 Psychiatriques : hospitalisations antérieures et suivi
 Habitudes toxiques : quantité et durée
 Gyneco-obstetricaux
 Juridiques

- Familiaux :

Médicaux
 Chirurgicaux
 Psychiatriques

D. Biographie

(Recueillie auprès de : malade, famille, autres accompagnateurs)

- Scolarité
- Puberté
- Vie sexuelle
- Vie professionnelle
- Personnalité du malade
- Fratrie
- Relations avec les parents et les frères
- Vie sociale
- Capacité d'établir des liens durables
- Capacité de maintenir des relations stables
- Intelligence (test)
- Hygiène corporelle et vestimentaire
- Faculté d'adaptation aux changements de lieux (voyages)

E. Histoire de la maladie

- Début
- Facteurs déclenchants et favorisants
- Chronologie
- Évolution de l'état actuel

F. Examen psychiatrique

1. LA PRESENTATION

- Tenue : négligée, adaptée
- Mimique : expressive, inexpressive, adaptée, inadaptée,
- Contact : facile, difficile, réticence, superficiel, hyper syntone
- Comportement : agitations, impulsions, stupeur, catalepsie, tics.

2. TROUBLES DES CONDUITES INSTINCTUELLES

- Contrôle sphinctérien de la miction et de la défécation
- Sommeil : insomnie, somnolence diurne, hypersomnie, perturbation de
- L'activité onirique
- Conduites alimentaires : Restrictions alimentaires, Refus alimentaires, Excès alimentaires
- Comportement sexuel: dysfonction sexuelle, paraphilies,

3. TROUBLES DES CONDUITES SOCIALES

- Suicide, tentative de suicide, équivalents suicidaires
- Fugues
- Vols pathologiques
- Attentats aux mœurs
- Homicide
- Actes incendiaires
- Agressions

4. CONDUITES ADDICTIVES

- Trouble de l'usage d'une substance
- Trouble addictif
- Dépendance comportementale

5. TROUBLES DES FONCTIONS SUPERIEURES

- Troubles du Langage : Logorrhée, mutisme, bégaiement, Aphasies, paralogisme, néologisme
- Troubles de la mémoire : Déficit mnésique : amnésie de fixation, rétrograde, antéro-rétrograde, lacunaire.
- Troubles du fonctionnement de la pensée et du jugement :
 - ⇒ Troubles du cours de la pensée : Tachypsychie ; bradypsychie, barrages idéiques, diffuence de la pensée
 - ⇒ Troubles du contenu de la pensée : Idées obsédantes / délirantes / dépressives/ Phobies

- ⇒ Distorsion globale de la pensée : Autistique, Magique, Paralogique, Rationalisme morbide
- ⇒ Troubles du jugement : Facilitation du jugement, Carence du jugement, Distorsion du jugement

6. Troubles de la perception

- Hallucinations
- Psychosensorielles
- Psychiques
- Absence de subjectivité
- Absence de sensorialité
- Sd d'automatisme mental

7. Conscience du soi et de l'environnement

- Troubles de la vigilance
- Conscience, attention, orientation temporo-spatiale
- Hypo ou hyper vigilance
- Etats crépusculaires
- Etats seconds
- Dépersonnalisation
- Déréalisation

8. Trouble des affects

- Hyperémotivité
- Anxiété
- Inadéquation
- Dépressive
- Expansive
- Indifférente

G. Examen physique

- Constantes hémodynamiques++
- Cardiovasculaire++
- Pulmonaire
- Neurologique++

H. Bilan complémentaire

- ECG ++
- EEG (surtout sujet âgé)
- Ionogramme sanguin
- FNS

- Bilan thyroïdien
- Bilan hépatique
- Bilan rénal
- Bilan toxicologique

Ce bilan est standard à l'admission, il sera complété en fonction des signes d'appel.

I. Conclusion

Reprendre les informations pertinentes

J. Discussion diagnostique

K. Conduite à tenir

Orientation du patient : (suivi ambulatoire, hospitalisation en soins libres, en soins sans consentement...)

L. Évolution

Sur le plan comportemental ; cognitif ; affectif ; instinctuel et physique.

M. Surveillance

Constantes++ (pouls, FR, température) ; ECG++ ; état de conscience, transit et miction, alimentation, sommeil, imprégnation NL.

N. Pronostic

Tant que le malade présente une forme clinique de sa pathologie accessible au traitement ; tant qu'il a un bon insight avec une bonne adhérence thérapeutique et tant que le support socio-familial est de bonne qualité = on reste optimiste quant à l'évolution.